

FICHE DE RÉVISION – LE SQUELETTE (VISION AMBULANCIER)

🎯 **Objectif** : connaître le squelette pour **localiser une douleur, décrire un traumatisme et transmettre clairement**, sans jargon inutile.

Le squelette sert à **situer**, pas à diagnostiquer.

1. Rôles du squelette

Le squelette permet : - le **soutien** du corps - 🛡️ la **protection** des organes vitaux - le **mouvement** (avec les muscles) - la **fabrication des cellules sanguines** (moelle osseuse)

2. Organisation générale du squelette

Deux grandes parties

A. Squelette axial (axe du corps)

- Crâne
- Colonne vertébrale
- Cage thoracique (côtes + sternum)

Protège cerveau, moelle épinière, cœur, poumons.

B. Squelette appendiculaire (membres)

- Membres supérieurs
- Membres inférieurs
- Ceintures scapulaire et pelvienne

Permet la mobilité.

3. Les grands os à connaître (indispensables examen)

● Crâne

- Protège l'encéphale
 - Traumatismes crâniens = vigilance neurologique
-

● Colonne vertébrale

- Cervicale (cou) – 7 vertèbres

- Thoracique (dos) – 12 vertèbres
- Lombaire (bas du dos) – 5 vertèbres
- Sacrum + coccyx

Toute douleur rachidienne post-traumatique = immobilisation.

● **Cage thoracique**

- Sternum
- 12 paires de côtes

Protège cœur et poumons.

● **Membre supérieur**

- Clavicule
 - Scapula (omoplate)
 - Humérus
 - Radius / Ulna
 - Carpe – Métacarpe – Phalanges
-

● **Membre inférieur**

- Bassin
- Fémur
- Rotule
- Tibia / Fibula
- Tarse – Métatarse – Phalanges

Fémur et bassin = os à risque hémorragique.

4. Articulations (repères simples)

- Épaule
- Coude
- Poignet
- Hanche
- Genou
- Cheville

Douleur articulaire = localisation précise obligatoire.

5. Lien squelette → traumatisme → transmission

Exemple terrain : - Chute avec douleur au bras

Transmission correcte :

« Douleur localisée au tiers moyen de l'humérus droit, impotence fonctionnelle. »

Incorrect :

« Fracture du bras. »

6. Erreurs fréquentes à éviter

Confondre droite et gauche Dire « au bras » ou « à la jambe » Nommer une fracture sans imagerie

7. Phrase sécurité jury

« Je localise la douleur sur le squelette, je décris les signes, le diagnostic relève du médecin. »

8. Schéma de repérage – Noms des os (lecture verticale)

À lire **de haut en bas**, comme un balayage clinique.

Tête

- Crâne
- Mandibule

Colonne vertébrale

- Vertèbres **cervicales** (C1 à C7)
- Vertèbres **thoraciques** (T1 à T12)
- Vertèbres **lombaires** (L1 à L5)
- Sacrum
- Coccyx

Cage thoracique

- Sternum
- Côtes (12 paires)

Ceinture scapulaire (épaule)

- Clavicule
- Scapula (omoplate)

Membre supérieur

- Humérus
- Radius (côté pouce)
- Ulna (cubitus)
- Carpe
- Métacarpe
- Phalanges

Ceinture pelvienne

- Bassin (os iliaque)

Membre inférieur

- Fémur
- Rotule
- Tibia
- Fibula (péroné)
- Tarse
- Métatarse
- Phalanges

Zones à risque hémorragique : **bassin – fémur**.

9. Mémo final – SQUELETTE

L.O.S.T. - Localiser l'os - Observer (douleur, déformation, mobilité) - Sécuriser (immobiliser si besoin) - Transmettre clairement

Si tu appliques LOST, tu es précis, crédible et propre à l'examen.